

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES

ISI – NF21 : Business & Data Understanding

Respiratory Risk Analytics

Pollution Atmosphérique et Maladies Respiratoires

Rapport d'Analyse de Données

Méthodologie CRISP-DM

Sources de données : EDGAR (Émissions)
GBD 2023 (Maladies)

Période : 1980 – 2022

Couverture : 197 pays

14 décembre 2025

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	Objectifs de l'étude	4
I	Business Understanding	5
2	Contexte Général	5
3	Question Métier et Objectifs	5
4	Enjeux du Projet	6
4.1	Enjeux environnementaux	6
4.2	Enjeux sanitaires	6
4.3	Enjeux économiques	6
4.4	Enjeux sociaux	6
5	Objectifs Métier	6
6	Jeux de Données	7
6.1	Données EDGAR	7
6.2	Données IHME : Global Burden of Disease	7
7	Périmètre Analytique	7
8	Parties Prenantes	8
8.1	Commanditaire principal	8
8.2	Équipe projet	8
8.3	Acteurs secondaires	8
9	Risques et Hypothèses	8
9.1	Risques identifiés	8
9.2	Hypothèses	8
II	Data Understanding	9
10	Indicateurs et Chaînes de Valorisation	9
10.1	Indicateurs clés	9
10.2	Chaînes de valorisation	10
10.2.1	Chaîne 1 – Analyse des corrélations polluants-maladies	10
10.2.2	Chaîne 2 – Analyse géographique et temporelle	11
10.2.3	Chaîne 3 – Analyse sectorielle des émissions	12
11	Description des Données	13
11.1	Vue d'ensemble	13
11.2	Polluants étudiés (EDGAR)	13
11.3	Maladies respiratoires (GBD)	13
12	Qualité des Données	14
12.1	Valeurs manquantes	14
12.2	Jointure des données	14

13 Analyse Exploratoire	15
13.1 Distribution des émissions par polluant	15
13.2 Comparaison hommes/femmes	16
14 Évolutions Temporelles	17
14.1 Tendances des émissions (1980–2022)	17
14.2 Tendances des décès (1980–2022)	17
15 Analyse Géographique	18
15.1 Pays les plus émetteurs	18
15.2 Pays avec les taux de mortalité les plus élevés	18
15.3 Cartographie des maladies respiratoires	19
15.4 Cartographie des émissions de polluants	20
16 Analyse Sectorielle	21
16.1 Secteurs d'activité	21
16.2 Relation secteur-polluant	22
17 Analyse des Corrélations	23
17.1 Corrélations polluants-maladies	23
17.2 Matrice de corrélation complète	24
17.3 Relations détaillées (scatter plots)	25
18 Synthèse de l'Analyse Exploratoire	26
18.1 Qualité des données	26
18.2 Principales conclusions	26
18.3 Recommandations pour la modélisation	26
III Data Preparation	27
19 Jeux de données (rappel)	27
20 Extraction des données	27
21 Prétraitement des données	28
21.1 Fusion des données	28
21.2 Stockage des données	29
21.3 Chaîne de valeur du prétraitement des données	30
21.3.1 Chaîne 4 – Préparation et intégration des données	30
22 Préparation pour la modélisation	31
22.1 Décalage temporel (Lag)	31
22.2 Gestion des valeurs manquantes	32
22.3 Transformations des features	32
22.3.1 Transformation logarithmique	32
22.3.2 Normalisation des features	32
22.4 Sélection des features et cibles	33
22.5 Séparation train/test	33
22.6 Implémentations	33
22.7 Analyse des scenarii	33
23 Synthèse de la préparation des données	34

IV	Modelization	35
24	Réflexions préliminaires	35
24.1	Modèles, machine-learning et deep-learning	35
24.2	Technologies choisies	35
24.3	Méthodes d'évaluation d'un modèle	36
25	Implémentation itérative des modèles	36
25.1	Modèle de machine learning scikit-learn	36
25.1.1	Ridge	36
26	Conclusion générale	37
 Liste des codes sources		
1	Extraction des données EDGAR avec Polars	28
2	Aggrégation du dataset combiné pour la corrélation	29
3	Analyse des décalages temporels par maladie	31
4	Sortie du script de préparation des données et présentation du dataset final . . .	34

1 Introduction

La pollution atmosphérique constitue aujourd’hui l’un des principaux déterminants environnementaux de santé. Ses effets sur les pathologies respiratoires sont largement documentés, mais leur ampleur et leur dynamique varient selon les territoires, les périodes et les types de polluants.

Le projet **Respiratory Risk Analytics** s’inscrit dans cette perspective. Il vise à mieux comprendre les interactions entre les émissions atmosphériques et l’évolution des maladies respiratoires à l’échelle mondiale. En s’appuyant sur des bases de données reconnues et actualisées, le projet cherche à fournir des éléments factuels pour aider les décideurs à identifier les zones les plus sensibles et à prioriser les actions de réduction de la pollution.

Ce rapport couvre les deux premières phases de la méthodologie CRISP-DM :

- **Business Understanding** : compréhension du contexte métier, des enjeux et des objectifs du projet
- **Data Understanding** : exploration et analyse des données disponibles

1.1 Objectifs de l’étude

- Comprendre et quantifier la relation entre la pollution atmosphérique et l’incidence des maladies respiratoires
- Identifier les zones prioritaires d’intervention
- Analyser les tendances temporelles des émissions de polluants atmosphériques
- Étudier la distribution géographique des maladies respiratoires
- Identifier les corrélations entre polluants et pathologies
- Préparer les données pour la phase de modélisation

Première partie

Business Understanding

2 Contexte Général

Ce projet s'inscrit dans le champ de la santé publique et de l'environnement, deux domaines où les interactions entre qualité de l'air et santé humaine constituent des préoccupations majeures. L'augmentation de la fréquence des épisodes de pollution et la progression des maladies respiratoires en font un enjeu prioritaire pour les autorités sanitaires nationales et internationales. Les politiques publiques s'appuient désormais fortement sur les données pour orienter les stratégies territoriales de prévention et d'intervention.

Plusieurs acteurs sont impliqués dans cette dynamique : les collectivités territoriales, les agences de santé publique, les ministères en charge de la santé et de l'environnement, ainsi que les organisations européennes comme la Commission Européenne. Les citoyens, directement exposés aux risques liés à la pollution atmosphérique, représentent la première population bénéficiaire du projet. Dans ce contexte institutionnel riche, le recours à une analyse *data-driven* constitue un outil d'aide à la décision essentiel.

3 Question Métier et Objectifs

L'objectif global du projet Respiratory Risk Analytics consiste à comprendre et quantifier la relation entre la pollution atmosphérique et l'incidence des maladies respiratoires dans le monde. Cette question métier répond à un besoin décisionnel réel : identifier les zones prioritaires d'intervention et mesurer l'impact potentiel ou réel des politiques publiques de réduction de la pollution.

La question centrale formulée est la suivante : « **Quelle est la relation entre la pollution atmosphérique et l'incidence des maladies respiratoires à l'échelle mondiale ?** ».

Plusieurs sous-questions guident cette problématique :

- **Diagnostiquer** : identifier les zones où les émissions et les maladies respiratoires sont les plus élevées
- **Expliquer** : analyser les liens temporels entre variations de pollution et variations de santé
- **Prédire** : estimer l'évolution potentielle des maladies à partir des niveaux de pollution
- **Recommander** : proposer des actions prioritaires

4 Enjeux du Projet

Les enjeux sont multiples et concernent plusieurs dimensions :

4.1 Enjeux environnementaux

La réduction des émissions de polluants constitue un impératif lié à la fois aux réglementations européennes et à la protection de la biodiversité.

4.2 Enjeux sanitaires

La pollution atmosphérique est reconnue comme un facteur aggravant majeur pour des pathologies telles que l’asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et les infections respiratoires aiguës.

4.3 Enjeux économiques

Une diminution de l’incidence des maladies respiratoires permettrait une réduction des dépenses hospitalières, des coûts de prise en charge et des pertes de productivité liées aux arrêts de travail.

4.4 Enjeux sociaux

Les enjeux sociaux touchent directement la qualité de vie des populations, notamment les plus vulnérables.

Ce projet présente ainsi une forte valeur ajoutée, car il vise à éclairer la décision publique et à cibler les zones où les actions de réduction de la pollution atmosphérique auraient l’effet le plus significatif.

5 Objectifs Métier

Le projet se fixe plusieurs objectifs métier :

1. **Identification des zones prioritaires** : grâce à une démarche de data mining, identifier les zones géographiques où les marges de réduction de la pollution sont les plus fortes et où les interventions publiques peuvent avoir un impact significatif.
2. **Réduction de l’incidence** : proposer des solutions permettant de réduire l’incidence des maladies respiratoires de 5% dans les zones les plus sensibles, et de diminuer de 10% les émissions des polluants les plus dangereux pour la santé.
3. **Identification des polluants critiques** : identifier les polluants ayant l’impact le plus important sur la santé respiratoire à l’échelle mondiale.

6 Jeux de Données

Pour répondre à ces objectifs, deux principaux jeux de données externes ont été identifiés.

6.1 Données EDGAR

EDGAR (Emissions Database for Global Atmospheric Research) : Base de données de la Commission Européenne contenant les émissions de polluants atmosphériques par pays, année et secteur d'activité.

Les données se présentent sous forme de fichiers Excel contenant environ 6 000 lignes par polluant. Les variables incluent :

- L'année (numérique)
- Le pays (catégoriel)
- Le secteur d'émission (catégoriel)
- Le type de polluant (catégoriel)
- La quantité d'émissions en gigagrammes (numérique)

Ces données permettent de suivre l'évolution des polluants majeurs (PM2.5, PM10, NOx, SO2, etc.) dans le temps.

6.2 Données IHME : Global Burden of Disease

GBD 2023 (Global Burden of Disease) : Étude de l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) fournissant les taux de mortalité standardisés par âge pour les maladies respiratoires.

Les fichiers CSV contiennent environ 30 000 lignes et décrivent les taux normalisés d'incidence et de mortalité pour 100 000 habitants. Les variables incluent :

- L'année (numérique)
- Le pays (catégoriel)
- Le sexe (catégoriel)
- Les taux d'incidence et de décès (numériques)

Ces deux jeux de données sont complémentaires et permettent une analyse spatio-temporelle robuste. La littérature scientifique, notamment les travaux de Santé Publique France, confirme l'existence d'un lien entre pollution atmosphérique et santé respiratoire, justifiant pleinement leur mise en relation.

7 Périmètre Analytique

Le périmètre analytique du projet est défini comme suit :

TABLE 1 – Périmètre du projet

Dimension	Périmètre
Couverture géographique	Ensemble des pays du monde (197 pays)
Période	1980–2022
Polluants	PM2.5, PM10, NOx, SO2, CO, NH3, NMVOC, BC, OC
Maladies	Asthme, BPCO, cancer du poumon, pneumoconioses, maladies pulmonaires interstitielles

Hors périmètre : Les analyses à l'échelle intra-urbaine, ou celles portant sur les déterminants sociaux individuels, ne sont pas incluses en raison du manque de données disponibles.

8 Parties Prenantes

8.1 Commanditaire principal

L'**Agence Régionale de Santé (ARS)** constitue une partie prenante centrale dans ce projet, à la fois comme utilisatrice directe des analyses produites et comme actrice opérationnelle des décisions qui pourront en découler. En tant qu'autorité sanitaire de proximité, l'ARS est chargée de mettre en œuvre au niveau régional les politiques nationales liées à la prévention, à la surveillance épidémiologique et à la protection de la santé des populations.

Dans le contexte de la pollution atmosphérique, l'ARS joue un rôle d'interface entre les données scientifiques, les acteurs locaux et les décisions publiques. Les résultats du projet pourront être mobilisés pour ajuster les plans régionaux santé-environnement, cibler les territoires les plus vulnérables et renforcer les dispositifs de prévention.

8.2 Équipe projet

L'équipe projet est composée d'analystes et de spécialistes des données chargés de transformer les données brutes (EDGAR, IHME) en indicateurs intelligibles.

8.3 Acteurs secondaires

Les résultats du projet sont également destinés à des acteurs secondaires :

- **Santé Publique France** : intégration des indicateurs dans la surveillance sanitaire nationale
- **Observatoires régionaux de la qualité de l'air (ATMO)** : relais de l'information à l'échelle locale
- **Collectivités territoriales** (métropoles, régions) : déploiement des actions concrètes de réduction des émissions
- **Organismes de recherche** spécialisés en climat, pollution ou santé publique

9 Risques et Hypothèses

9.1 Risques identifiés

Plusieurs risques concernent la qualité et la comparabilité des données :

- Les méthodes de mesure diffèrent selon les pays
- Certaines séries peuvent être incomplètes
- Des facteurs socio-économiques non observés peuvent introduire des biais
- La granularité géographique est limitée à l'échelle des pays

9.2 Hypothèses

Les hypothèses principales du projet reposent sur :

- La fiabilité des données EDGAR et IHME
- La comparabilité des observations dans le temps et entre pays
- L'existence d'un lien statistique entre pollution atmosphérique et maladies respiratoires

Deuxième partie

Data Understanding

10 Indicateurs et Chaînes de Valorisation

Dans le cadre de la méthodologie CRISP-DM, cette section présente les indicateurs clés et les chaînes de valorisation identifiées pour l'exploration des données sur la pollution atmosphérique et les maladies respiratoires.

10.1 Indicateurs clés

TABLE 2 – Indicateurs identifiés pour l'étude

Indicateur	Description	Unité
Émissions totales par polluant	Somme des émissions annuelles par type de polluant	Kilotonnes (kt)
Taux de mortalité standardisé	Décès pour 100 000 habitants ajusté par âge	Taux / 100 000 hab.
Corrélation polluant-maladie	Coefficient de Pearson entre émissions et mortalité	[-1, 1]
Part sectorielle	Pourcentage des émissions par secteur d'activité	%
Tendance temporelle	Variation annuelle moyenne des émissions/mortalité	% / an

10.2 Chaînes de valorisation

Trois chaînes de valorisation principales ont été identifiées pour cette phase d'exploration.

10.2.1 Chaîne 1 – Analyse des corrélations polluants-maladies

Objectif : Identifier les liens statistiques entre les émissions de polluants atmosphériques et les taux de mortalité par maladie respiratoire.

TABLE 3 – Chaîne 1 – Corrélations polluants-maladies

Tâche générique (TG)	Tâches spécifiques (TS)	Outils
TG11 – Collecte et Intégration	Télécharger les données EDGAR (émissions) et GBD (mortalité), extraire les fichiers Excel/CSV	Python (requests), Excel, CSV
TG12 – Préparation et Mise en qualité	Harmoniser les noms de pays (ISO 3166), traiter les valeurs manquantes, uniformiser les unités	Polars, Pandas
TG13 – Traitement et Analyse	Calculer les matrices de corrélation, identifier les associations significatives	Python (scipy, numpy), Omniscope
TG14 – Restitution et Visualisation	Générer les heatmaps de corrélation, scatter plots polluant vs maladie	Matplotlib, Seaborn, Omniscope

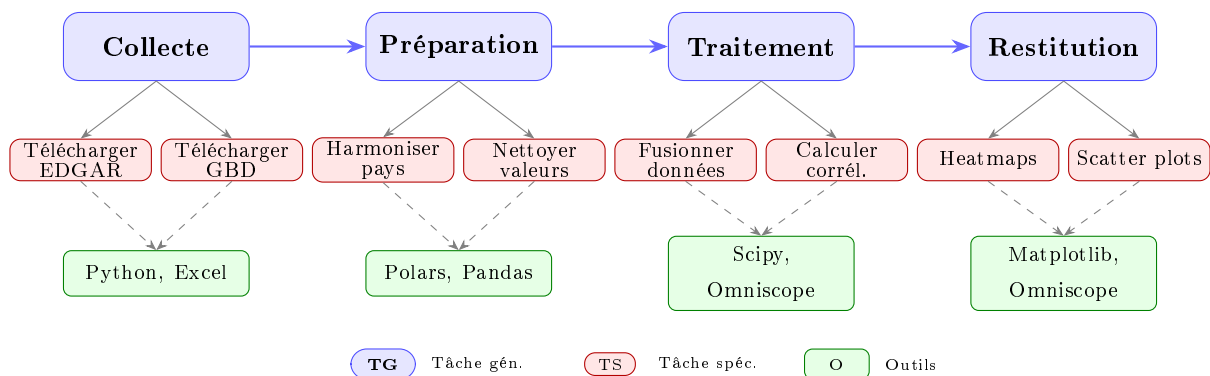


FIGURE 1 – Schéma de la chaîne 1 – Corrélations polluants-maladies

10.2.2 Chaîne 2 – Analyse géographique et temporelle

Objectif : Comprendre la distribution spatiale et l'évolution temporelle des émissions et de la mortalité respiratoire.

TABLE 4 – Chaîne 2 – Analyse géographique et temporelle

Tâche générique (TG)	Tâches spécifiques (TS)	Outils
TG21 – Collecte et Intégration	Joindre les données EDGAR et GBD sur code ISO pays et année	Polars (join)
TG22 – Préparation et Mise en qualité	Agréger par pays-année, filtrer la période commune (1980-2022), 197 pays	Polars (group_by, filter)
TG23 – Traitement et Analyse	Calculer les classements (top émetteurs, top mortalité), tendances temporelles	Python (numpy, pandas), Omnisciope
TG24 – Restitution et Visualisation	Graphiques bar charts par pays, courbes d'évolution temporelle	Matplotlib, Seaborn, Omnisciope

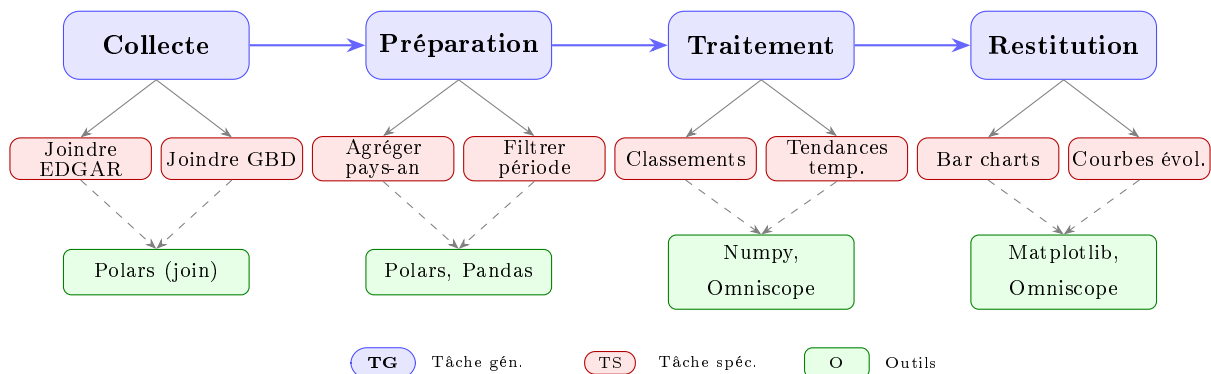


FIGURE 2 – Schéma de la chaîne 2 – Analyse géographique et temporelle

10.2.3 Chaîne 3 – Analyse sectorielle des émissions

Objectif : Identifier les secteurs d'activité les plus polluants pour orienter les analyses et recommandations.

TABLE 5 – Chaîne 3 – Analyse sectorielle

Tâche générique (TG)	Tâches spécifiques (TS)	Outils
TG31 – Collecte et Intégration	Extraire les données EDGAR avec granularité sectorielle (IPCC categories)	Python, Excel
TG32 – Préparation et Mise en qualité	Regrouper les secteurs par catégorie IPCC, normaliser les noms	Polars, Pandas, Omniscope
TG33 – Traitement et Analyse	Calculer les émissions totales par secteur et polluant, identifier les associations secteur-polluant	Python (numpy), Omniscope
TG34 – Restitution et Visualisation	Heatmap secteur-polluant, bar charts des top secteurs	Matplotlib, Seaborn, Omniscope

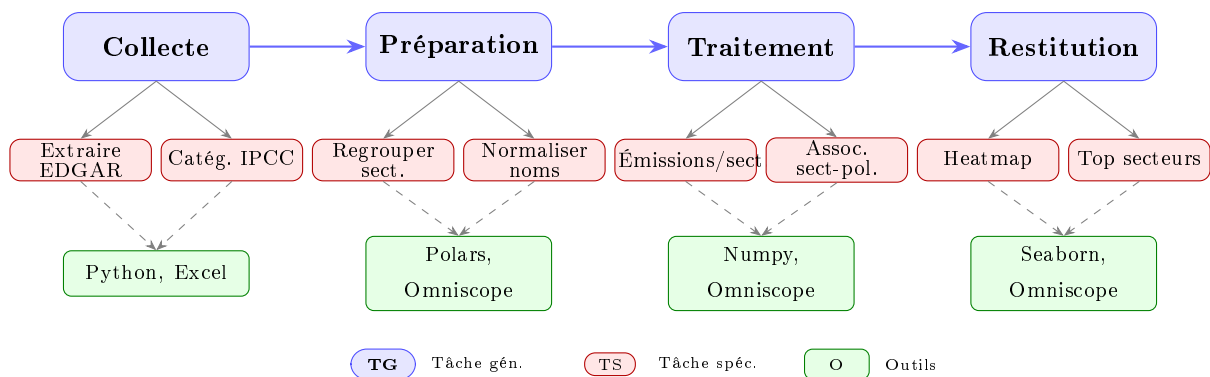


FIGURE 3 – Schéma de la chaîne 3 – Analyse sectorielle des émissions

11 Description des Données

11.1 Vue d'ensemble

TABLE 6 – Caractéristiques des jeux de données

Caractéristique	EDGAR	GBD 2023
Nombre de pays	215	204
Période	1970–2022	1980–2023
Variables	9 polluants	5 maladies
Granularité	Pays, année, secteur	Pays, année, sexe
Unité	Kilotonnes (kt)	Taux pour 100 000 hab.

11.2 Polluants étudiés (EDGAR)

1. **PM2.5** : Particules fines ($< 2.5\mu m$)
2. **PM10** : Particules ($< 10\mu m$)
3. **NOx** : Oxydes d'azote
4. **SO2** : Dioxyde de soufre
5. **CO** : Monoxyde de carbone
6. **NH3** : Ammoniac
7. **NMVOC** : Composés organiques volatils non méthaniques
8. **BC** : Carbone noir
9. **OC** : Carbone organique

11.3 Maladies respiratoires (GBD)

1. Cancer de la trachée, des bronches et des poumons
2. Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
3. Asthme
4. Pneumoconioses
5. Maladies pulmonaires interstitielles

12 Qualité des Données

12.1 Valeurs manquantes

L'analyse des valeurs manquantes révèle une excellente complétude des données. Le taux de valeurs manquantes global est inférieur à 0.01%, principalement concentré dans les correspondances de noms de pays entre les deux sources.

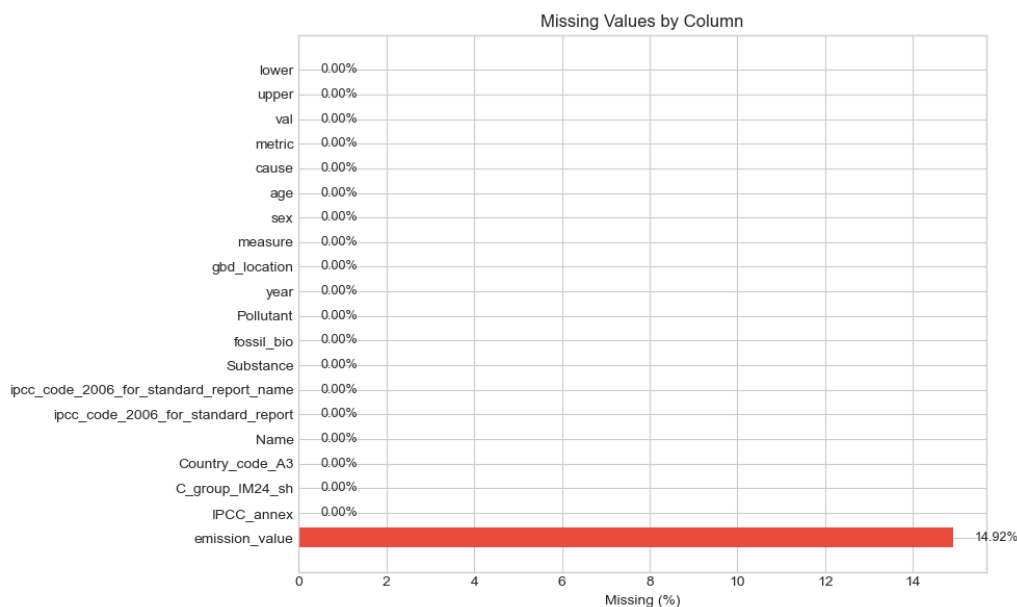


FIGURE 4 – Distribution des valeurs manquantes par variable

12.2 Jointure des données

La jointure des deux sources de données (EDGAR et GBD) a été réalisée sur :

- Le code ISO à 3 lettres des pays (197 pays communs)
- L'année (période commune : 1980–2022)

Le dataset final contient **38 millions d'observations** après jointure complète, et **63 445 observations** après agrégation par pays-année.

13 Analyse Exploratoire

13.1 Distribution des émissions par polluant

La figure 5 montre la distribution des émissions pour chaque polluant. On observe une forte asymétrie positive (skewness) pour tous les polluants, avec quelques pays émettant des quantités significativement supérieures à la moyenne mondiale.

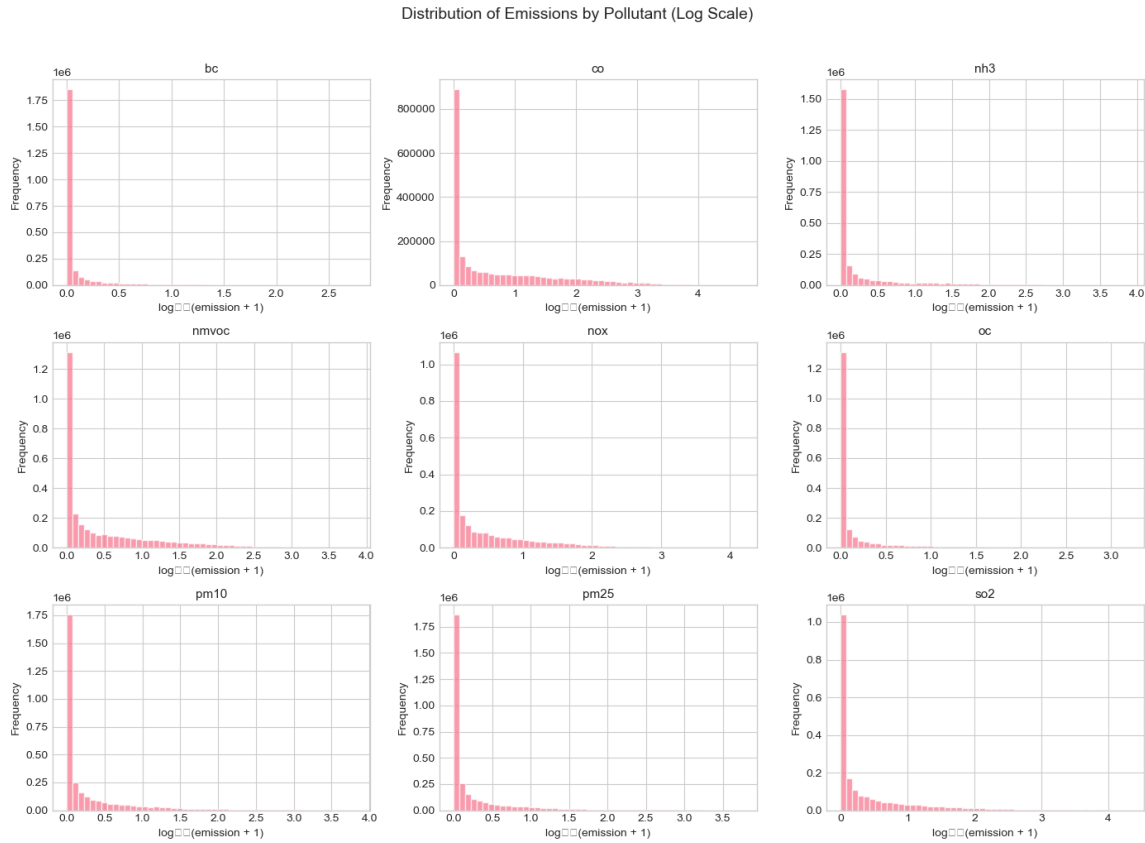


FIGURE 5 – Distribution des émissions par polluant (échelle logarithmique)

13.2 Comparaison hommes/femmes

L'analyse par sexe révèle des différences significatives dans les taux de mortalité. Les hommes présentent des taux plus élevés pour la majorité des maladies respiratoires, notamment pour le cancer du poumon et les MPOC.

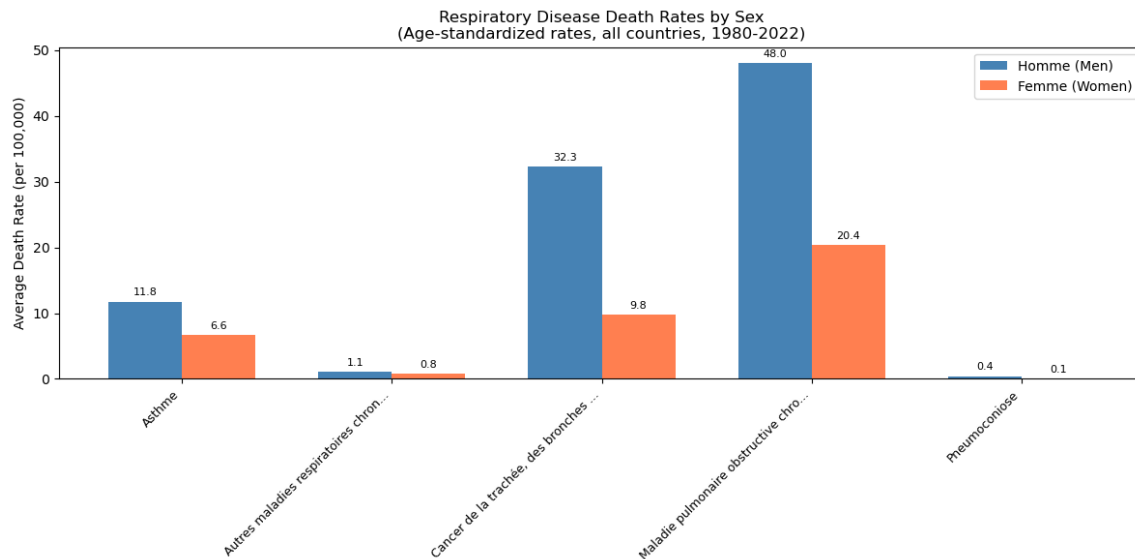


FIGURE 6 – Comparaison des taux de mortalité par sexe

14 Évolutions Temporelles

14.1 Tendances des émissions (1980–2022)

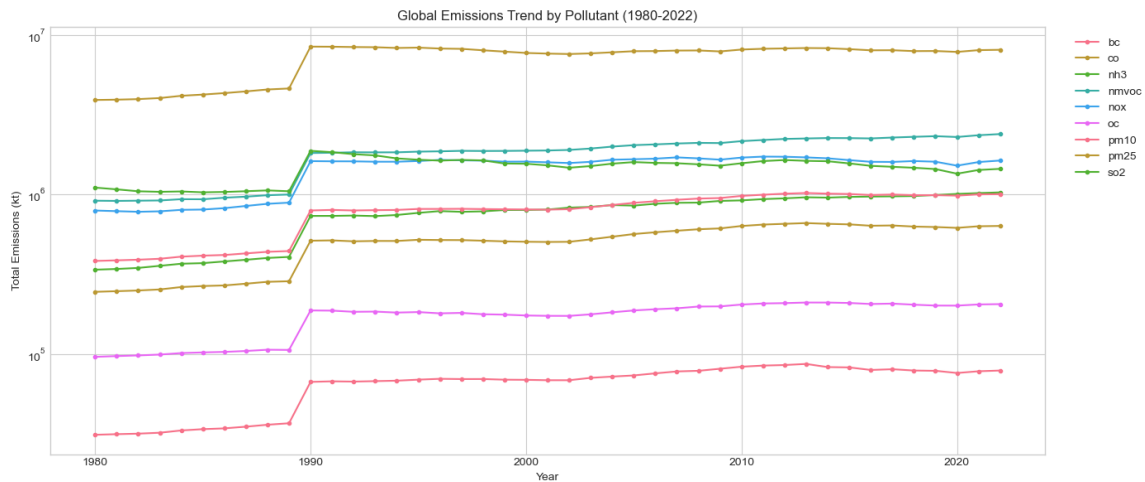


FIGURE 7 – Évolution temporelle des émissions mondiales par polluant

Observations clés :

- Pics d'émissions en 1990 pour tous les polluants
- Tous les polluants semblent très corrélés
- L'Oxide de Carbone (CO) est le polluant le plus présent

14.2 Tendances des décès (1980–2022)

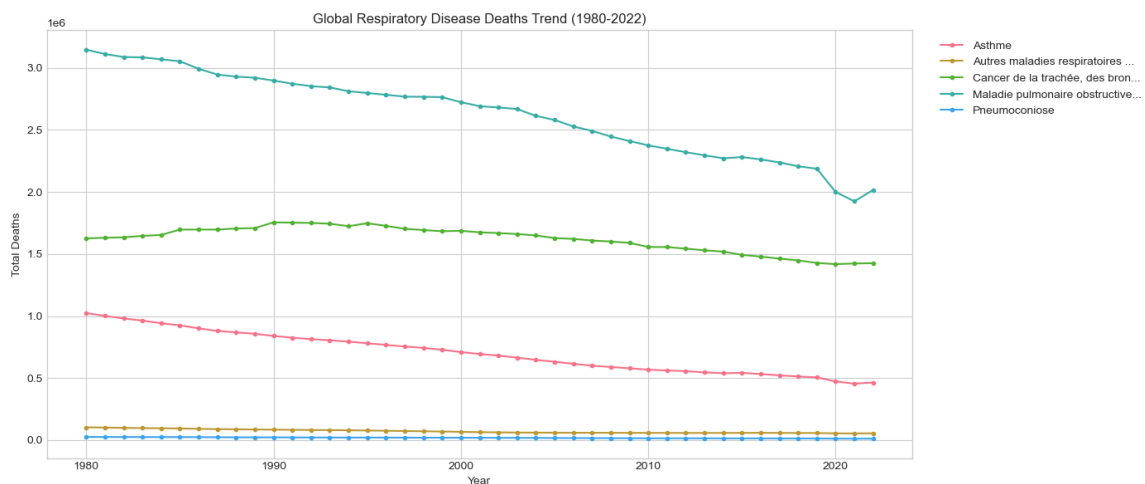


FIGURE 8 – Évolution temporelle des taux de mortalité par maladie

Observations clés :

- Diminution globale des taux de mortalité pour les MPOC
- Stabilité relative du cancer du poumon
- Baisse significative de l'asthme mortel

15 Analyse Géographique

15.1 Pays les plus émetteurs

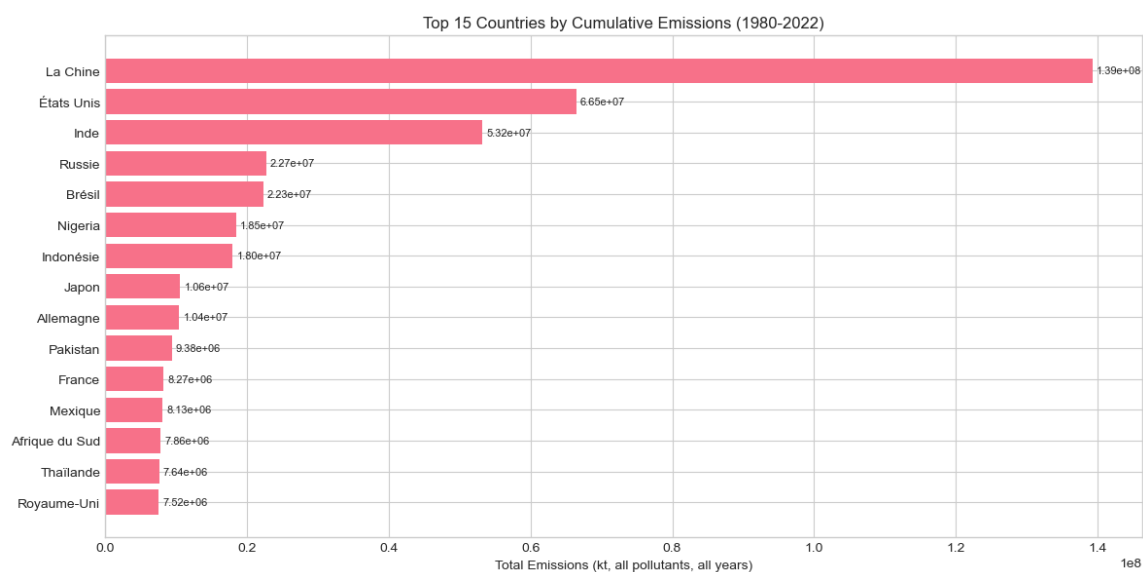


FIGURE 9 – Top 15 des pays émetteurs (toutes émissions confondues)

Les plus grands émetteurs sont la Chine, les États-Unis, l'Inde et la Russie, reflétant leur activité industrielle et leur population.

15.2 Pays avec les taux de mortalité les plus élevés

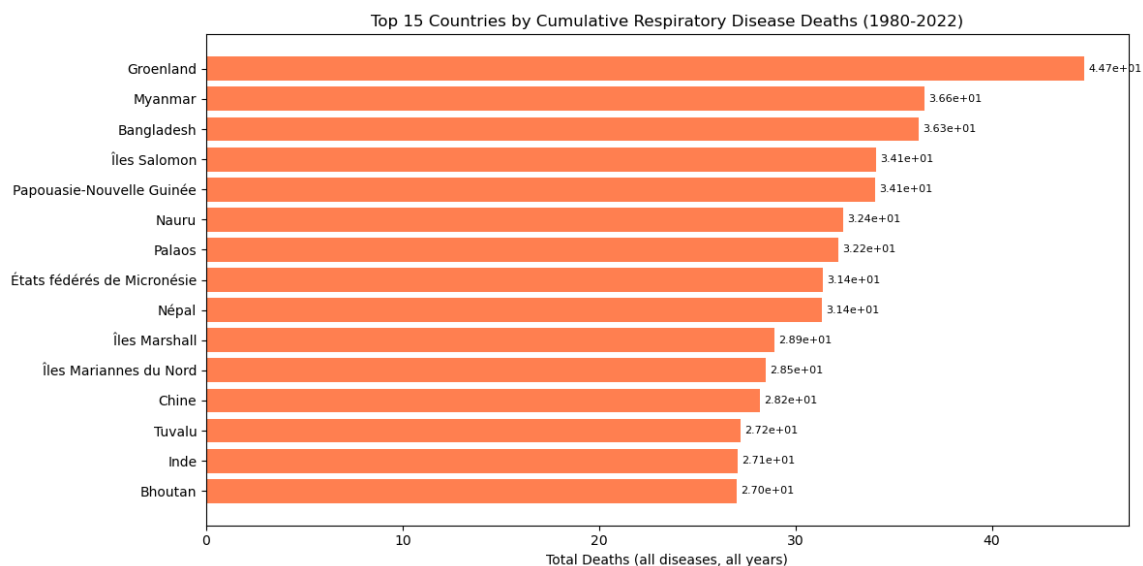


FIGURE 10 – Top 15 des pays par taux de mortalité respiratoire

15.3 Cartographie des maladies respiratoires

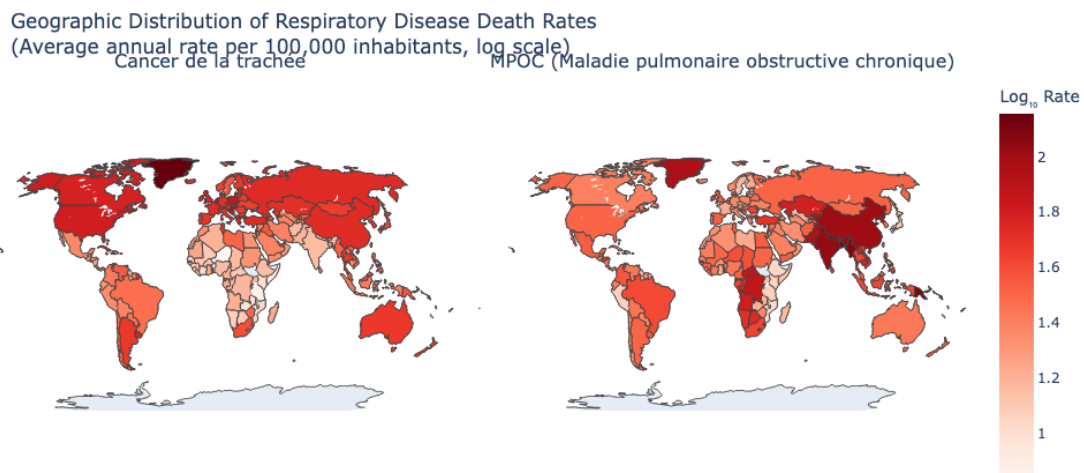


FIGURE 11 – Distribution géographique des taux de mortalité (cancer de la trachée et MPOC)

Observations :

- Le cancer de la trachée présente des taux élevés en Europe de l'Est, Amérique du Nord et Océanie
- La MPOC touche particulièrement l'Asie du Sud-Est (Chine, Inde) et certains pays africains
- Les pays développés montrent des patterns différents selon la maladie

15.4 Cartographie des émissions de polluants

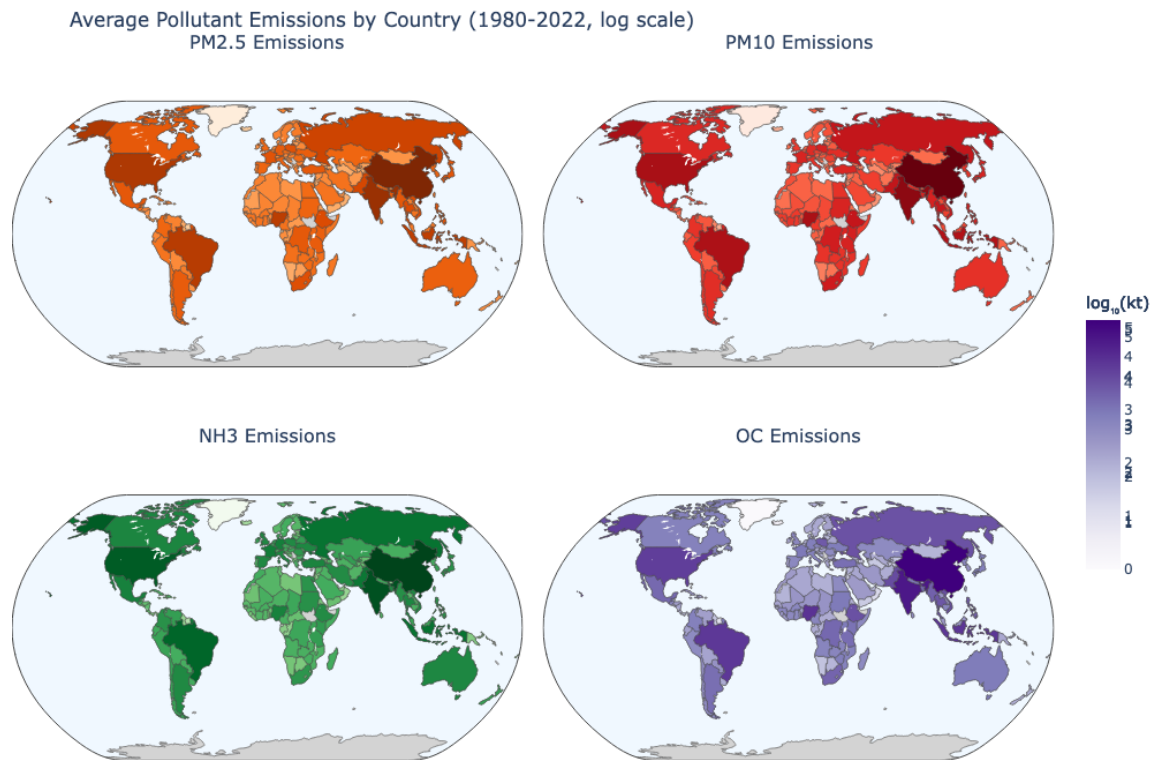


FIGURE 12 – Distribution géographique des émissions (PM2.5, PM10, NH3, OC)

Observations :

- La Chine et les États-Unis dominent pour tous les polluants
- Les particules fines (PM2.5, PM10) montrent des répartitions similaires
- L'ammoniac (NH3) est particulièrement élevé dans les pays à forte activité agricole (Inde, Chine, Brésil, États-Unis, Russie)
- Le carbone organique (OC) suit une distribution proche de celle des particules fines

16 Analyse Sectorielle

16.1 Secteurs d'activité

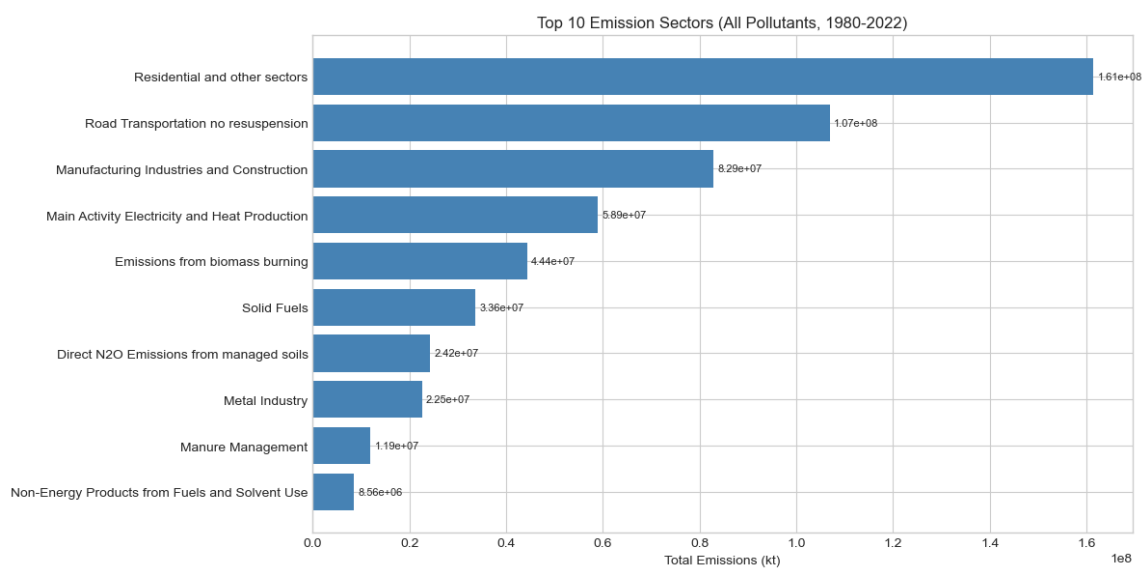


FIGURE 13 – Top 10 des secteurs d'activité par émissions totales

Les secteurs dominants sont :

- Transport routier
- Industrie manufacturière
- Production d'énergie
- Agriculture

16.2 Relation secteur-polluant



FIGURE 14 – Heatmap des émissions par secteur et polluant

Cette heatmap révèle les associations secteur-polluant : le transport routier est associé aux NOx et CO, tandis que l'agriculture domine les émissions de NH3.

17 Analyse des Corrélations

17.1 Corrélations polluants-maladies

La matrice de corrélation entre polluants et maladies respiratoires constitue le cœur de cette étude exploratoire.

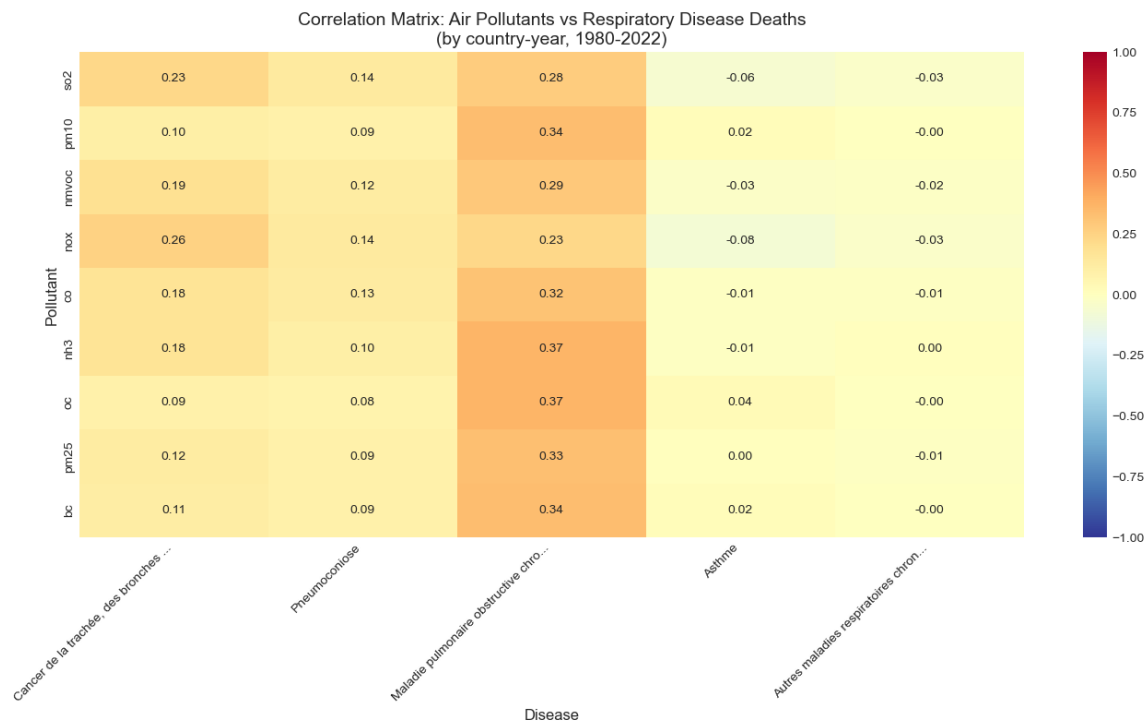


FIGURE 15 – Matrice de corrélation : polluants vs maladies respiratoires

Corrélations notables :

- PM2.5 et PM10 montrent des corrélations positives modérées avec toutes les maladies
- NH3 et OC présentent les corrélations les plus fortes avec le cancer du poumon
- les MPOC est corrélée à la plupart des polluants

17.2 Matrice de corrélation complète

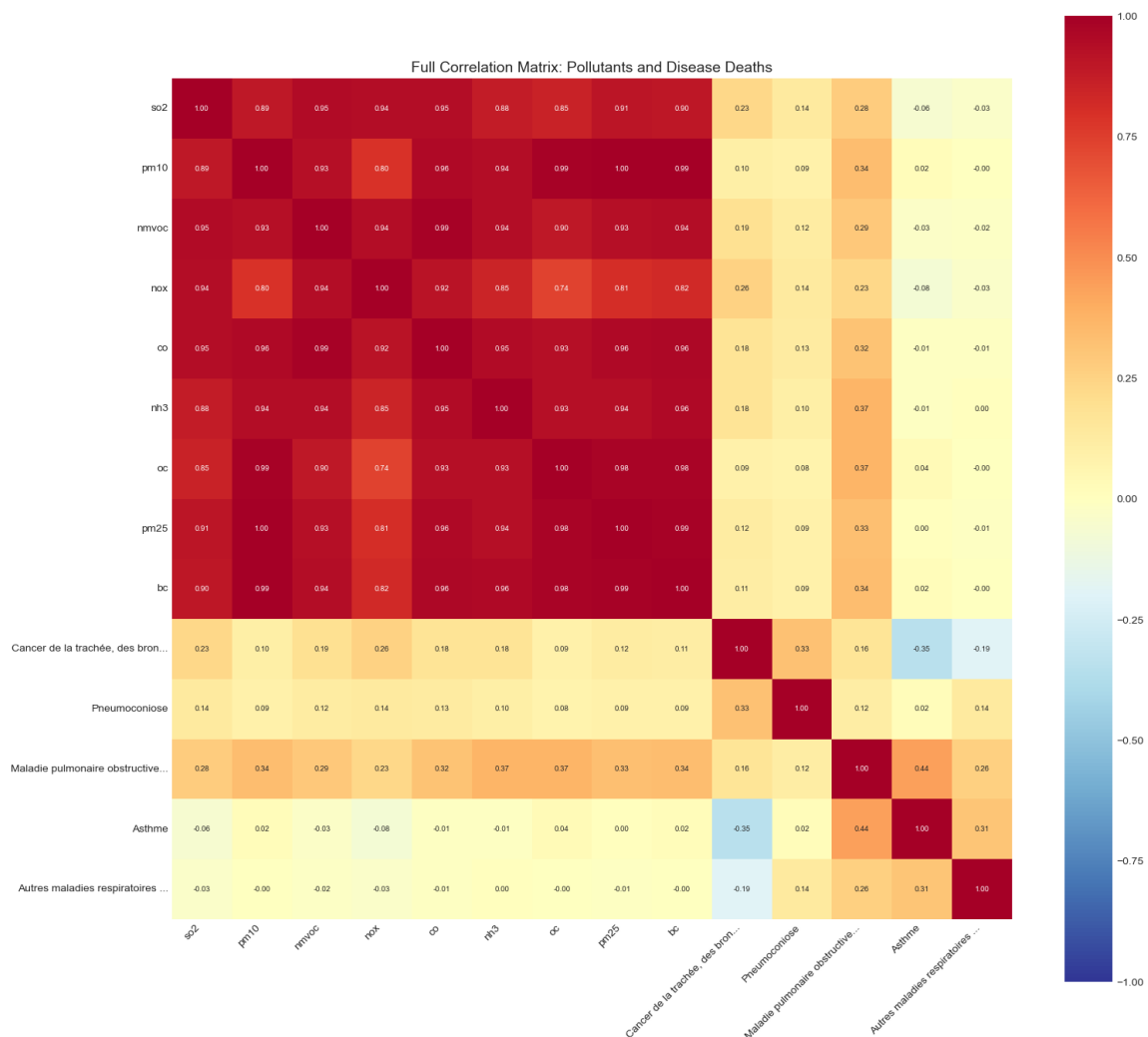


FIGURE 16 – Matrice de corrélation complète (polluants et maladies)

Observations :

- Forte multicolinéarité entre polluants ($r > 0.8$ pour la plupart)
- Les maladies sont également corrélées entre elles
- Ces corrélations suggèrent des facteurs communs (développement économique, urbanisation)
- les MPOC semblent plus corrélées aux polluants que les autres maladies (notamment NM-VOC, OC, PM10 et PM25)

17.3 Relations détaillées (scatter plots)



FIGURE 17 – Scatter plots : polluants clés vs maladies (échelle log)

18 Synthèse de l'Analyse Exploratoire

18.1 Qualité des données

TABLE 7 – Résumé de la qualité des données

Critère	Évaluation
Complétude	Excellente ($> 99.99\%$)
Couverture géographique	197 pays
Couverture temporelle	43 ans (1980–2022)
Cohérence des unités	Vérifiée
Outliers	$< 2\%$ (à traiter)

18.2 Principales conclusions

1. **Corrélations significatives** : Des corrélations positives modérées existent entre les polluants atmosphériques et les maladies respiratoires, particulièrement pour les particules fines (PM2.5, PM10), les NVMOC, l'Oxide de Carbone et le cancer du poumon ainsi que les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) .
2. **Multicolinéarité** : Les polluants sont fortement corrélés entre eux, ce qui nécessitera une attention particulière lors de la modélisation (régularisation, réduction de dimension).
3. **Disparités géographiques** : Les pays en développement présentent des taux d'émission croissants tandis que les pays développés montrent des tendances à la baisse.
4. **Différences par sexe** : Les hommes sont plus touchés par les maladies respiratoires, avec des taux de mortalité 2 à 3 fois supérieurs pour le cancer du poumon.
5. **Évolution temporelle** : Malgré l'augmentation des émissions globales, les taux de mortalité standardisés tendent à diminuer, suggérant l'impact positif des avancées médicales.

18.3 Recommandations pour la modélisation

- Appliquer une transformation logarithmique aux émissions
- Considérer une analyse en composantes principales (ACP) pour réduire la multicolinéarité
- Inclure des variables de contrôle (PIB, urbanisation, accès aux soins)
- Utiliser des modèles de panel pour exploiter la dimension temporelle
- Tester des modèles avec décalage temporel (lag) entre exposition et maladie

Troisième partie

Data Preparation

19 Jeux de données (rappel)

- **EDGAR** : <https://edgar.jrc.ec.europa.eu/>
- **GBD 2023** : <https://ghdx.healthdata.org/gbd-2023>

Pour plus de précisions, voir la section [Jeux de Données](#).

20 Extraction des données

Les données étant statiques et n'ayant pas pour but d'être récoltées périodiquement, elles ont simplement été téléchargées à la main depuis les sources respectives. Pour les données du dataset *EDGAR*, il a suffi de télécharger les différents fichiers Excel correspondant à chaque polluant sur le site de la Commission Européenne. Pour les données du dataset *GBD*, nous avons dû remplir plusieurs formulaires par paquets en prenant soin de sélectionner les mêmes critères de mesures afin de ne pas excéder les quotas, la réponse à notre demande d'extension des dits quotas étant arrivée assez tardivement.

21 Prétraitement des données

21.1 Fusion des données

La partie la plus considérable de l'étape de préparation des données s'est portée sur la création d'un dataset unique et cohérent à partir des données extraites. Ce travail a été effectué avant l'exploration des données : en effet, il est nécessaire de fusionner les données des différents datasets pour pouvoir les exploiter ensemble. Nous avons utilisé la bibliothèque *Polars* de Python pour effectuer cette fusion. En effet, malgré notre plus grande maîtrise de la bibliothèque *Pandas*, nous avons choisi d'utiliser *Polars* en raison de son efficacité et de sa capacité à gérer plus rapidement et efficacement des données relativement volumineuses. Cet outil, écrit en Rust, offre des performances bien supérieures et une syntaxe similaire à celle de *Pandas* (bien que parfois plus complexe), ce qui facilite la transition entre les deux bibliothèques. Dans les cas où nos connaissances de *Pandas* pouvaient permettre des opérations plus rapides (e.g. : avec *matplotlib* ou *seaborn*), une simple conversion avec `df.to_pandas()` suffit.

Ainsi, *polars* a été utilisé pour effectuer les opérations suivantes :

```
1 import polars as pl
2
3 edgar_dirs = [d for d in Path('data/EDGAR').iterdir() if d.is_dir()]
4
5 poll_dfs = {}
6
7 for subdir in edgar_dirs:
8     df = pl.read_excel(
9         list(subdir.glob('*.xlsx'))[0], engine='calamine',
10         read_options={"header_row": 9}
11     )
12     poll_dfs[code.lower()] = df
13
14 edgar = pl.concat(
15     [df.with_columns(pl.lit(name).alias("Pollutant")) for name, df in
16     ↪ poll_dfs.items()],
17     how="vertical"
```

Code 1 – Extraction des données EDGAR avec Polars

L'extraction des données GBD se fait de manière similaire. Un challenge a été les noms de pays : afin de fusionner les données EDGAR et GBD, nous devions joindre sur les années et les pays. Or, si EDGAR nous fournit des noms de pays en anglais et des codes ISO 3166-1 alpha-3, soit une catégorisation propre, GBD lui nous fournit des noms de pays en français mal traduit. En effet, même en naviguant le site en anglais avec un navigateur en anglais, le dataset GBD renvoie des noms de pays en français avec une traduction automatique. Ce qui donne des apostrophes mal encodés, des articles de manière aléatoire (e.g. : France, Espagne, mais "*La Chine*"). Cela nous a forcé à créer une table de traduction des noms de pays en français vers ceux en anglais, à la main, dans un dictionnaire `country_mapping` exporté dans un fichier CSV.

Une fois cela fait, il ne restait plus qu'à dépivoter les années du dataset EDGAR (qui étaient des colonnes au format Y_NNNN) et à fusionner les datasets, ce qui nous donne un énorme dataset qui regroupe sur une ligne pour chaque pays, chaque année, chaque polluant, chaque maladie et chaque industrie les émissions du polluant et les morts causés par la maladie. Ce dataset brut est intéressant pour une analyse préliminaire, mais il est nécessaire d'ensuite grouper les données simplement par pays, années et polluant pour obtenir un dataset plus exploitable.

```

1 emissions_agg = (
2     combined2
3     .group_by(['gbd_location', 'Country_code_A3', 'year', 'Pollutant'])
4     .agg(pl.col('emission_value').sum().alias('total_emission'))
5     .pivot(on='Pollutant', index=['gbd_location', 'Country_code_A3', 'year'],
6           ↪ values='total_emission')
7 )
8 ...
9
10 correlation_data = emissions_agg.join(
11     deaths_agg,
12     on=['gbd_location', 'Country_code_A3', 'year'],
13     how='inner'
14 )
15
16 correlation_data.write_parquet('data/combined/correlation_ready.parquet')
```

Code 2 – Aggrégation du dataset combiné pour la corrélation

```

Joined data for correlation : (8471, 17)
Countries : 197
Years : 43
Countries with ISO codes : 197
shape : (5, 17)
```

C'est à partir de ce dataset que nous avons obtenu notre matrice de corrélation et c'est à partir de celui-ci que nous avons commencé à développer notre modèle.

21.2 Stockage des données

Le dataset brut étant assez lourd, pour optimiser le stockage, nous avons utilisé le format *Parquet* afin de pouvoir facilement stocker, charger et manipuler les données. Cela permettait en outre de rendre plus facile le partage de ces fichiers, évitant des fichiers CSV de plusieurs gigaoctets contre seulement quelques mégaoctets.

Le format *Parquet*, un format binaire ouvert, est particulièrement adapté à notre utilisation de Polars, étant donné qu'il est supporté nativement et peut donc être lu et transformé en dataframe d'un simple appel à la méthode `read_parquet`. Sa structure columnaire stocke les données par colonnes plutôt que par lignes, ce qui est idéal pour les opérations analytiques où seules certaines colonnes sont nécessaires, réduisant ainsi les entrées-sorties. Contrairement aux fichiers texte comme le CSV, le caractère binaire de Parquet permet une compression avancée et une lecture plus rapide.

21.3 Chaîne de valeur du prétraitement des données

Une chaîne de valorisation a été identifiée pour la phase de préparation des données, regroupant l'extraction, le nettoyage, la fusion et le stockage.

21.3.1 Chaîne 4 – Préparation et intégration des données

Objectif : Construire un dataset unifié, cohérent et optimisé à partir des sources EDGAR et GBD pour permettre les analyses exploratoires et la modélisation.

TABLE 8 – Chaîne 4 – Préparation et intégration des données

Tâche (TG)	Tâche générique	Tâches spécifiques (TS)	Outils
TG41 – Extraction des données brutes		Télécharger les fichiers Excel EDGAR (par polluant), télécharger les CSV GBD (par paquets, respect des quotas), charger les fichiers avec Polars	Python, Polars (read_excel, read_csv), calamine
TG42 – Nettoyage et Harmonisation		Créer le mapping des noms de pays FR→EN, harmoniser les codes ISO 3166-1 alpha-3, traiter les valeurs manquantes et les apostrophes mal encodées	Polars, dictionnaire Python, CSV
TG43 – Transformation et Fusion		Dépivoter les colonnes années EDGAR (Y_NNNN), joindre EDGAR et GBD sur pays/année, agréger par pays/année/polluant pour la corrélation	Polars (unpivot, join, group_by, pivot)
TG44 – Stockage et Export		Exporter les datasets en format Parquet (compression, performance), vérifier l'intégrité des données	Polars (write_parquet)

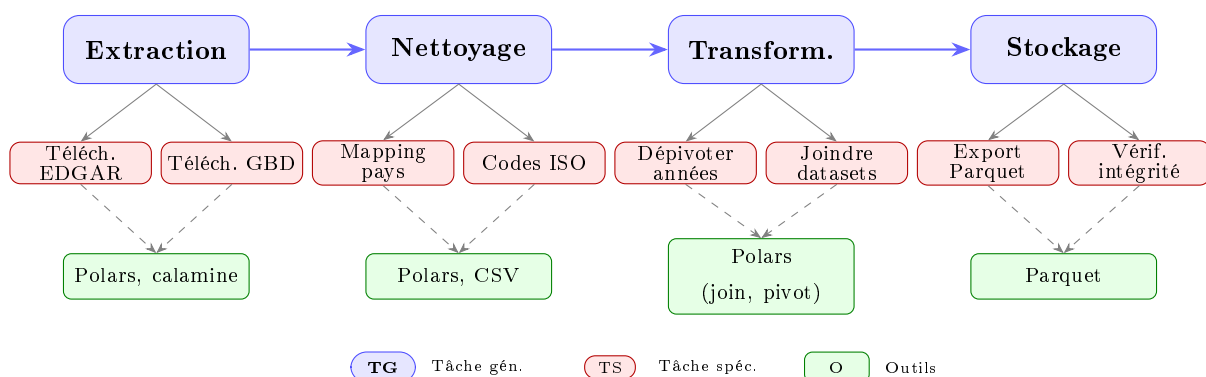


FIGURE 18 – Schéma de la chaîne 4 – Préparation et intégration des données

22 Préparation pour la modélisation

Une fois le dataset fusionné et stocké au format Parquet, les données doivent être préparées pour la modélisation prédictive. Cette étape comprend le chargement des données, l'application de transformations, la gestion des valeurs manquantes, la normalisation des features et la séparation train/test.

22.1 Décalage temporel (Lag)

Un point clef de la préparation pour la modélisation est l'introduction d'un décalage temporel entre les émissions (variables explicatives) et les décès (variable cible). En effet, il existe un délai biologique entre l'exposition à la pollution atmosphérique et le développement de maladies respiratoires. Dans notre cas, les données sont préparées de telle sorte que les émissions de l'année t prédisent les décès de l'année $t + lag$, où **lag** est le nombre d'années considérées.

Dans les faits, le décalage temporel a été testé et n'a pas permis d'améliorer les performances du modèle. Nous avons donc décidé de garder la fonctionnalité, mais de ne pas l'utiliser en choisissant un lag égal à zéro. Les résultats des tests de lag sont présentés ci-dessous :

```

1  LAG ANALYSIS BY DISEASE
2  =====
3
4  Random State: 1
5
6  Lung Cancer:
7    Lag 0 years | R² = 0.8567
8    Lag 3 years | R² = 0.8625
9    Lag 6 years | R² = 0.8720
10   Lag 9 years | R² = 0.8660
11
12  Pneumoconiosis:
13    Lag 0 years | R² = 0.8058
14    Lag 3 years | R² = 0.7868
15    Lag 6 years | R² = 0.7367
16    Lag 9 years | R² = 0.7928
17
18  COPD:
19    Lag 0 years | R² = 0.7937
20    Lag 3 years | R² = 0.7811
21    Lag 6 years | R² = 0.7924
22    Lag 9 years | R² = 0.8119
23
24  ...

```

Code 3 – Analyse des décalages temporels par maladie

Comme montré dans la sortie de script ci-dessus, les performances varient légèrement selon le décalage temporel choisi, mais aucun pattern consistant n'émerge. Un décalage de 0 années fournit un bon équilibre et reste notre choix par défaut.

22.2 Gestion des valeurs manquantes

Le dataset combiné contient quelques valeurs manquantes dues aux enregistrements manquants pour les émissions de polluants dans certains pays certaines années.

Nous avons opté pour la stratégie la plus simple et la plus robuste : **supprimer les lignes contenant des valeurs manquantes**. Cette approche, bien qu'elle réduise la taille du dataset, garantit la qualité des données utilisées pour le modèle et évite les artefacts introduits par l'imputation. L'imputation remplace les valeurs manquantes par une estimation statistique fixe calculée sur l'ensemble de la colonne, comme la moyenne, la médiane ou la valeur la plus fréquente. L'interpolation est une autre méthode possible, elle consiste à deviner la valeur manquante en observant la tendance des valeurs voisines (juste avant et juste après), souvent de manière linéaire. Elle est particulièrement adaptée aux séries temporelles, mais peut introduire des artefacts si les données sont bruitées ou si la tendance n'est pas linéaire.

22.3 Transformations des features

22.3.1 Transformation logarithmique

Les émissions de polluants présentent souvent une distribution asymétrique avec des valeurs aberrantes. Pour normaliser cette distribution et réduire l'influence des valeurs extrêmes, nous appliquons une transformation logarithmique :

$$x'_i = \log(1 + x_i)$$

où x_i est l'émission du polluant i . La constante additive 1 ($\log1p$) permet de gérer les valeurs zéro ou très proches de zéro sans générer d'erreurs numériques.

22.3.2 Normalisation des features

Après la transformation logarithmique, nous normalisons et réduisons toutes les features à l'aide d'un `StandardScaler` du framework de machine-learning *scikit-learn*. Cette normalisation ramène les features à une moyenne de 0 et un écart-type de 1 :

$$x'_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$$

où μ et σ sont la moyenne et l'écart-type estimés sur l'ensemble d'entraînement. Cette étape est essentielle pour les modèles sensibles à l'échelle (régression linéaire, réseaux de neurones, etc.).

22.4 Sélection des features et cibles

Pour la modélisation, nous utilisons les neuf polluants comme features explicatives :

- CO (Monoxyde de carbone)
- SO₂ (Dioxyde de soufre)
- NO_x (Oxydes d'azote)
- NMVOC (Composés organiques volatils non méthaniques)
- PM_{2.5} (Particules fines)
- PM₁₀ (Particules grossières)
- NH₃ (Ammoniac)
- BC (Carbone noir)
- OC (Carbone organique)

Pour les cibles (variables à prédire), nous avons sélectionné trois maladies respiratoires principales basées sur l'analyse exploratoire :

- **Lung Cancer** : Cancer de la trachée, des bronches et des poumons
- **Pneumoconiosis** : Pneumoconiose
- **COPD** : Maladie pulmonaire obstructive chronique

Les deux autres maladies (Asthme et Autres maladies respiratoires chroniques) ont été exclues car l'analyse exploratoire n'a révélé aucune corrélation significative avec les polluants étudiés.

22.5 Séparation train/test

Le dataset est divisé en deux ensembles :

- **Ensemble d'entraînement** (80%) : utilisé pour ajuster les paramètres du modèle et calibrer le `StandardScaler`
- **Ensemble de test** (20%) : utilisé pour évaluer les performances du modèle sur des données non vues pendant l'entraînement

Cette séparation en 80/20 est assez standard et permet une évaluation fiable des performances du modèle dans la grande majorité des cas.

22.6 Implémentations

Deux versions de la pipeline de préparation ont été implémentées dans le module `model.data_prep` :

- `prepare_data()` : pour scikit-learn, retournant un objet `PreparedData` avec les arrays NumPy
- `prepare_data_torch()` : pour PyTorch, retournant un objet `PreparedDataTorch` avec les tensors PyTorch

Les deux versions partagent la même logique de préparation et de normalisation, garantissant la cohérence entre les deux frameworks.

22.7 Analyse des scenarii

Le module inclut également des fonctions qui nous seront utiles dans la partie modélisation pour l'analyse de scenarii post-modélisation (`get_baseline_emissions()`, `create_scenario_features()`), permettant d'évaluer l'impact de réductions d'émissions sur la mortalité prédite. Cela facilite l'interprétabilité du modèle et le support à la décision.

23 Synthèse de la préparation des données

La préparation des données est une étape cruciale dans le processus qui doit aboutir à la modélisation. Une donnée mal préparée peut complètement ruiner un modèle. Il est donc capital de passer par les étapes de compréhension business, compréhension des données et de préparation des données, dans cet ordre. Bien qu'une partie de ce processus s'effectue dans le cadre de la compréhension des données, il faut noter que les objectifs sont différents : c'est pourquoi nous avons deux jeux de données : un pour l'exploration plus globale (plus fourni car encore à défricher) et un pour des observations plus fines et pour la modélisation (plus compact car déjà pré-traité). Le dataset utilisé pour la modélisation est le suivant :

```
1
2 Saved aggregated dataset: 8,471 rows × 17 columns
3 File: data/combined/correlation_ready.parquet
4
5 Columns: ['gbd_location', 'Country_code_A3', 'year', 'pm10', 'oc', 'nmvoc', 'nox',
6   ↪ 'pm25', 'nh3', 'co', 'so2', 'bc', 'Asthme', 'Cancer de la trachée, des bronches
   ↪ et des poumons', 'Pneumoconiose', 'Autres maladies respiratoires chroniques',
   ↪ 'Maladie pulmonaire obstructive chronique']
```

Code 4 – Sortie du script de préparation des données et présentation du dataset final

Quatrième partie

Modelization

24 Réflexions préliminaires

24.1 Modèles, machine-learning et deep-learning

L'étape du modèle du framework CRISP-DM implique la réflexion autour de modèles mathématiques permettant d'exprimer des relations entre nos données, relations qui peuvent s'avérer complexes et difficiles à identifier à l'œil nu. Ces modèles plus ou moins complexes, peuvent notamment se baser sur des méthodes statistiques ou des approches d'apprentissage automatique. Ces modèles sont stochastiques, c'est-à-dire non-déterministes. Ainsi, deux exécutions du même modèle avec les mêmes données mais des initialisations différentes peuvent produire des résultats différents, d'où l'importance d'une graine aléatoire (`random_state`) fixée pour assurer la reproductibilité.

L'apprentissage automatique (*machine learning*) regroupe des algorithmes qui apprennent automatiquement à partir des données sans être explicitement programmés. Ces algorithmes cherchent à identifier des patterns dans les données pour faire des prédictions sur de nouvelles données. On distingue plusieurs catégories : la régression (prédire une valeur continue), la classification (prédire une catégorie), le clustering (grouper les données), etc. Des exemples courants incluent la régression linéaire, les arbres de décision, les forêts aléatoires et les machines à vecteurs de support (SVM). Ces modèles sont généralement interprétables et relativement rapides à entraîner.

L'apprentissage profond (*deep learning*) est un sous-ensemble du machine learning basé sur les réseaux de neurones artificiels (artificial neural networks). Contrairement aux modèles classiques, les réseaux de neurones apprennent des représentations hiérarchiques des données, où chaque couche du réseau transforme les données en abstractions de plus en plus complexes. Bien que les réseaux de neurones soient plus exigeants en termes de données et de puissance de calcul, ils peuvent capturer des relations non-linéaires très complexes et sont particulièrement efficaces pour les données de haute dimension.

Dans notre contexte de prédiction de mortalité due à la pollution, nous explorons à la fois des modèles classiques de machine learning (pour l'interprétabilité et la performance) et des approches de deep learning (pour la flexibilité et la capacité à modéliser des relations complexes potentiellement cachées dans les données). Nous avons de prime abord choisi cette approche à des fins éducatives : à la fois dans le but de pratiquer ces différentes techniques et d'identifier leurs différences une fois mis en application, mais également pour démontrer leurs forces et leurs faiblesses.

24.2 Technologies choisies

Afin de mettre en œuvre un algorithme de machine learning, nous nous sommes dirigés vers la bibliothèque *scikit-learn*. *sklearn*, de son nom abrégé, est une bibliothèque Python open-source qui implémente de nombreux algorithmes de machine learning. C'est le standard dans l'industrie et du côté de la recherche pour le machine learning dit "classique", de la préparation des données à la modélisation. Scikit-learn et les algorithmes de machine learning qu'il implémente sont particulièrement adaptés aux problèmes de régression sur des données tabulaires comme le notre. *PyTorch*, quant à elle, est une bibliothèque Python open-source développée par Meta pour le deep learning.

PyTorch n'est a priori pas l'outil idéal pour traiter un problème de régression simple comme le notre : il peut fonctionner, mais l'intérêt des réseaux de neurones se situe dans leur capacité à représenter les données d'une manière beaucoup plus complexe, par exemple en utilisant des

couches de convolution pour traiter des images. Ayant déjà travaillé avec ces deux bibliothèques, nous savons donc que PyTorch introduit une complexité supplémentaire qui n'est a priori pas nécessaire pour notre problème. Cependant, toujours pour des raisons éducatives, nous avons décidé de traiter les deux, avec un réseau de neurones basique pour PyTorch et un modèle d'arbres de décision pour scikit-learn. Nous aurons donc deux modèles, et en réalité plus que cela en raison des différentes variables cibles.

24.3 Méthodes d'évaluation d'un modèle

Il existe une multitude de méthodes pour évaluer de prime abord les performances d'un modèle. Les deux que nous verrons ici sont l'écart quadratique moyen (RMSE, pour *Root Mean Squared Error*) et le coefficient de détermination (R^2), qui divise la somme des erreurs du modèle (ou résidus) au carré, par la variance du jeu de données, afin de mesurer la qualité de la prédiction.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2} \quad (1)$$

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (2)$$

$\hat{y}_i$: la prédiction du modèle pour la donnée i

y_i : la valeur réelle de la donnée i

$\bar{y}$: la moyenne des valeurs réelles

25 Implémentation itérative des modèles

25.1 Modèle de machine learning scikit-learn

Dans un premier temps, le temps de calcul et l'écriture du code étant très rapide avec scikit-learn une fois nos données prétraitées et nos features/targets définies, nous avons décidé de comparer plusieurs algorithmes de machine learning pour trouver le meilleur modèle. Nous avons utilisé les algorithmes suivants :

- Ridge (régression linéaire)
- Forêts aléatoires
- Boost de Gradients

25.1.1 Ridge

26 Conclusion générale

Références

- EDGAR v8.0 : <https://edgar.jrc.ec.europa.eu/>
- GBD 2023 : <https://ghdx.healthdata.org/gbd-2023>
- Méthodologie CRISP-DM : https://moodle.utt.fr/pluginfile.php/13371/mod_resource/content/1/CRISP-DM.pdf